

Pracetam 1200

- Tên thuốc**
Pracetam 1200
Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc
Để sa lâm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
- Thành phần công thức thuốc**
Thành phần hoạt chất:
Pracetam..... 1200 mg
Thành phần tá dược:
Powidon K25, colloidal silica khan, croscarmellose natri, magnesi stearat, opadry vàng, eudragit NE 30 D, simethicon.
- Dạng bào chế**
Viên nén bao phim.
Viên nén hình thuẫn, bao phim màu vàng nhạt, khắc vạch có hai mặt.
- Chỉ định**
Điều trị triệu chứng các rối loạn não hữu cơ mạn tính như một phần của khả năng điều trị tổng thể cho hội chứng sa sút trí tuệ với các triệu chứng chính: rối loạn trí nhớ, rối loạn tập trung, rối loạn tư duy, mệt mỏi sớm, thiếu động lực và động cơ, rối loạn cảm xúc. Nhóm đối tượng chính bao gồm bệnh nhân mắc hội chứng sa sút trí tuệ ở thể sa sút trí tuệ thoái hóa nguyên phát, sa sút trí tuệ do nhồi máu não và các dạng hỗn hợp của hai.
Không thể dự đoán được đáp ứng của từng bệnh nhân với thuốc.
Lưu ý:
Trước khi bắt đầu điều trị với pracetam, cần làm rõ liệu các triệu chứng có phải là bệnh lý cơ bản cần được điều trị cụ thể hay không.
Điều trị hỗ trợ chứng rung giật cơ có nguồn gốc từ vỏ não.
- Cách dùng, liều lượng**
Cách dùng
Pracetam 1200 được dùng bằng đường uống, có thể cùng hoặc không cùng với thực ăn. Nên uống viên bao phim với chất lỏng. Liều hàng ngày được khuyến cáo chia làm 2 – 4 lần.
Liều dùng
Liều lượng phụ thuộc vào loại và mức độ nghiêm trọng của bệnh cảnh lâm sàng và đáp ứng của bệnh nhân với liệu pháp điều trị.
Hướng dẫn sử dụng liều trong điều trị hội chứng sa sút trí tuệ ở người lớn:
1 viên nén bao phim Pracetam 1200 x 2 lần/ngày (tương đương 2,4 g pracetam). Theo hướng dẫn của bác sĩ, có thể tăng liều lên 2 viên nén bao phim Pracetam 1200 x 2 lần/ngày (tương đương 4,8 g pracetam).
Hướng dẫn sử dụng liều trong điều trị hỗ trợ hội chứng rung giật cơ có nguồn gốc từ vỏ não ở người lớn:
Khi bắt đầu điều trị, 2 viên nén bao phim Pracetam 1200 x 3 lần/ngày (tương đương 7,2 g pracetam). Sau đó, tùy vào đáp ứng của từng bệnh nhân, liều hàng ngày tăng hơn 4 viên nén bao phim mỗi 3 ngày. Liều hàng ngày tối đa là 20 viên nén bao phim, chia 2 – 3 lần.
Trong quá trình điều chỉnh liều, điều trị với các thuốc trị rung giật cơ khác nên được duy trì ở cùng liều lượng.
Nên giảm liều từ từ khi có giật co kết thúc.
Khi đã bắt đầu điều trị, nên tiếp tục điều trị chừng nào bệnh nhân cần nguyên vẫn còn tồn tại. Ở những bệnh nhân có một cơn giật co cấp tính, bệnh có thể tiến triển tới sau một khoảng thời gian. Vì vậy, một ít thông tin thủ giảm liều hoặc ngưng điều trị. Để làm được điều này, nên giảm 1,2 g pracetam mỗi 2 ngày (mỗi 3 hoặc 4 ngày trong trường hợp có hội chứng Lance-Adams) nhằm ngăn ngừa khả năng tái phát đợt ngất hoặc co giật do ngưng thuốc đột ngột.
Điều chỉnh liều ở người cao tuổi
Nên điều chỉnh liều ở người cao tuổi bị suy giảm chức năng thận (xem “Điều chỉnh liều ở bệnh nhân suy giảm chức năng thận”). Theo dõi thường xuyên để thành thử creatinin khi điều trị lâu dài ở người cao tuổi để điều chỉnh liều phù hợp nếu cần.
Điều chỉnh liều ở bệnh nhân suy giảm chức năng thận
Pracetam được thải trừ hoàn toàn qua thận, nên chức năng thận giảm có thể dẫn đến tăng thời độ thuốc trong huyết tương. Do đó, liều hàng ngày phải được xác định ở từng cá nhân tùy thuộc vào chức năng thận. Việc điều chỉnh liều nên được thực hiện theo bảng dưới đây. Để dùng bảng phân liều này, đo thành thử creatinin (μmol/L) của bệnh nhân để ước tính bằng miliphot. CL_{cr} (lít sáng miliphot) có thể được xác định từ creatinin huyết thanh (mg/dl) theo công thức sau:
$$CL_{cr} = \frac{[140 - \text{tuổi (năm)}] \times \text{cân nặng (kg)}}{72 \times \text{creatinin huyết thanh (mg/dl)}} \times (0,85 \text{ ở phụ nữ})$$

Nhóm	Độ thanh thải creatinin (ml/phút)	Liều lượng và tần suất sử dụng
Bình thường	> 80	Liều thường dùng hàng ngày, chia 2 - 3 lần.
Nhẹ	50 – 79	2/3 liều thường dùng hàng ngày, chia 2 hoặc 3 lần.
Trung bình	30 – 49	1/3 liều thường dùng hàng ngày, chia 2 lần.
Nặng	< 30	1/6 liều thường dùng hàng ngày, dùng 1 lần.
Bệnh nhân thận phân máu	–	Chống chỉ định.

Điều chỉnh liều ở bệnh nhân suy giảm chức năng gan
Pracetam không được chuyển hóa ở gan. Không có hướng dẫn liều đặc biệt nào áp dụng cho những bệnh nhân bị suy giảm chức năng gan. Nên chỉnh liều khi dùng cho bệnh nhân vừa suy gan và suy thận (xem “Điều chỉnh liều ở bệnh nhân suy giảm chức năng thận”).
Khoảng thời gian sử dụng
Thời gian điều trị phải được quyết định bởi bác sĩ.
Trong điều trị hỗ trợ các hội chứng sa sút trí tuệ, sau 3 tháng cần kiểm tra xem có còn chỉ định điều trị thêm hay không.
Trong điều trị hỗ trợ hội chứng rung giật cơ có nguồn gốc từ vỏ não phụ thuộc vào diễn biến lâm sàng. Nếu hội chứng rung giật không còn xảy ra, nên chấm dứt từ từ liệu pháp điều trị bằng Pracetam 1200.
- Chống chỉ định**
Quá mẫn với pracetam, các dẫn xuất pyridolone khác hoặc bất kỳ tá dược nào của thuốc.
Bệnh nhân bị xuất huyết não (như đột quỵ do xuất huyết).
Bệnh nhân suy thận, nên theo dõi chặt chẽ nồng độ nito hoặc creatinin còn lại.
Bệnh nhân bị bệnh thận giai đoạn cuối.
Bệnh nhân bị chứng mùa gặt Huntington.
- Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc**
Pracetam 1200 chỉ được sử dụng với tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết trong trường hợp bốn chôn về lâm thần.
Tác dụng trên kết tập tiểu cầu
Do tác động của pracetam trên kết tập tiểu cầu, nên thận trọng khi dùng Pracetam 1200 ở những bệnh nhân bị rối loạn đông máu, có nguy cơ chảy máu như loét dạ dày, cần tiến hành phẫu thuật lớn bao gồm phẫu thuật nha khoa, xuất huyết nặng, tiền sử xuất huyết, tai biến mạch máu não và ở những bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông máu hoặc thuốc chống kết tập tiểu cầu bao gồm các acid acetylsalicylic liều thấp.
- Suy thận**
Pracetam được thải trừ qua thận, nên đặc biệt thận trọng ở bệnh nhân suy thận.
Người cao tuổi
Khi điều trị lâu dài ở người cao tuổi, cần kiểm tra để thành thử creatinin thường xuyên để điều chỉnh liều nếu cần.
- Chăm sóc điều trị**
Nên cảnh giác điều trị đột ngột ở những bệnh nhân bị rung giật cơ, vì điều này có thể dẫn đến tái phát hoặc co giật liên tục đến khi ngừng thuốc.
Ở những bệnh nhân cần dùng thuốc chống co giật, nên đảm bảo rằng liệu pháp này được duy trì, ngay cả khi có sự cải thiện chủ quan trong quá trình điều trị bằng pracetam.
- Tá dược**
Pracetam 1200 có chứa dưới 1 mmol (23 mg) trong mỗi viên, về cơ bản được xem như “không chứa natri”.
- Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú**
Phụ nữ có thai
Chưa có đủ kinh nghiệm về việc sử dụng pracetam trong thời kỳ mang thai. Pracetam đi qua nhau thai. Nồng độ thuốc trong huyết tương ở thai nhi khoảng 90 – 90% nồng độ của người mẹ. Các nghiên cứu về độc tính sinh sản trên động vật không cho thấy bằng chứng nào về đặc tính gây quái thai hoặc gây độc cho phôi thai của pracetam.
Không nên dùng pracetam trong thời kỳ mang thai trừ khi lợi ích mang lại nhiều hơn nguy cơ và tình trạng lâm sàng của phụ nữ mang thai cần điều trị bằng pracetam.
Phụ nữ cho con bú
Pracetam được bài tiết qua sữa mẹ và không được sử dụng trong thời kỳ cho con bú, hoặc không cho con bú trong thời gian điều trị bằng pracetam. Nên tính đến lợi ích của việc bú sữa mẹ đối với trẻ và lợi ích của điều trị đối với mẹ khi quyết định không cho con bú hoặc không sử dụng pracetam.
- Phụ nữ có khả năng sinh sản**
Không có đủ liều lâm sàng có sẵn về ảnh hưởng của pracetam đối với khả năng sinh sản. Các nghiên cứu trên động vật chỉ ra rằng pracetam không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở chuột đực hoặc chuột cái.
- Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc**
Do các tác dụng không mong muốn quan sát được của Pracetam 1200 không thể loại trừ sự suy giảm khả năng phản ứng và cần lưu ý điều này khi chủ động lái xe và vận hành máy móc.

- Tương tác, tương kỵ của thuốc**
Tương tác của thuốc
Tương tác được đồng học
Khả năng tương tác thuốc ảnh hưởng đến động học của pracetam là thấp vì khoảng 90% liều dùng được bài tiết qua nước tiểu dưới dạng không đổi.
Ở nồng độ 142, 426 và 1422 μg/ml, pracetam không ức chế isoenzym cytochrom P450 CYP 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 và 4A8/1 trong *in vitro*.
Ở nồng độ 1422 μg/ml, các tác dụng ức chế nhẹ đối với isoenzym CYP 2A6 (21%) và 3A4/5 (11%) đã được quan sát thấy. Tuy nhiên, giá trị Ki đối với sự ức chế của hai isoenzym này đều trên nồng độ 1422 μg/ml. Do đó, tương tác chuyển hóa của pracetam với các thuốc khác khó xảy ra.
Các hormon tuyến giáp
Liều lớn, kéo dài và rối loạn giấc ngủ đã được báo cáo khi điều trị đồng thời với chất thay thế tuyến giáp (T3 + T4).
Acenocoumarol
Trong một nghiên cứu mù đôi đã được công bố ở những bệnh nhân bị huyết khối tĩnh mạch bị phát hiện, pracetam liều 9,6 g mỗi ngày không ảnh hưởng đến liều acenocoumarol, cần thiết để đạt được INR 2,5 đến 3,5. So với tác dụng của acenocoumarol đơn thuần, việc dùng thêm 9,6 g pracetam mỗi ngày làm giảm đáng kể sự kết tập của các tiểu cầu trong máu, giải phóng β-thromboglobulin, nồng độ fibrinogen và các yếu tố Willebrand (VIII: C, VIII: vW: Ag, VII: vW: RCo) cũng như độ nhớt của máu và huyết tương.
Thuốc chống đông kinh
Liều hàng ngày 20 g pracetam trong 4 tuần không ảnh hưởng đến nồng độ đỉnh và nồng độ đáy trong huyết thanh của thuốc chống đông kinh (carbamazepine, phenytoin, phenobarbital, valproate) ở những nhân bị động kinh dùng liều liên tục.
Thuốc kích thích thần kinh trung ương (amfetamin, amphetamine)
Tác dụng của thuốc kích thích thần kinh trung ương và thuốc an thần kinh có thể tăng lên.
Rượu
Sử dụng đồng thời với rượu không ảnh hưởng đến nồng độ pracetam trong huyết thanh, và nồng độ rượu không bị ảnh hưởng khi uống 1,6 g pracetam.
Tương kỵ của thuốc
Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc với các thuốc khác.
- Tác dụng không mong muốn của thuốc**
Thường gặp (>10% ≤ ADR < 1/10)
– Tâm thần: Căng thẳng, hưng hăng, rối loạn giấc ngủ.
– Hệ thần kinh: Tăng động.
– Khác: Tăng cân.
Ít gặp (1/1000 ≤ ADR < 1/100)
– Tâm thần: Trầm cảm.
– Hệ thần kinh: Buồn ngủ.
– Mạch: Giảm hoặc tăng huyết áp.
– Toàn thân và tai chõ dùng thuốc: Suy nhược, tăng ham muốn, tăng khả năng tính dục.
Rất hiếm gặp (ADR < 1/10.000)
– Da và mô dưới da: Đỏ da và độ bùng mặt.
– Toàn thân và tai chõ dùng thuốc: Đổ mồ hôi.
Chưa biết (không thể ước tính từ các dữ liệu có sẵn)
– Máu và hệ bạch huyết: Bệnh xuất huyết.
– Hệ miễn dịch: Phản ứng dị ứng như phản ứng phản vệ, quá mẫn.
– Tâm thần: Tăng hoạt động tâm thần vận động, lo âu, trạng thái lú lẫn, ảo giác.
– Hệ thần kinh: Mất điều hòa vận động, rối loạn cân bằng, đau đầu, đột cấp của bệnh động kinh, mất ngủ.
– Tai và tai trong: Hoa mắt.
– Tiểu hóa: Khó chịu ở bụng, tiểu chảy, buồn nôn, nôn.
– Da và mô dưới da: Phù Quinke, viêm da, mẩn ngứa, mày đay.
– Ở người lớn, các tác dụng không mong muốn được ghi nhận ở liều khoảng 5 g pracetam mỗi ngày. Ở trẻ em, các tác dụng không mong muốn tương đương được quan sát thấy ở liều khoảng 3 g pracetam mỗi ngày.
- Qua liều và cách xử trí**
Triệu chứng
Không có thêm tác dụng không mong muốn nào được mô tả với pracetam đặc biệt là liên quan đến quá liều.
Trường hợp quá liều có thể được báo cáo là 75 g pracetam dùng đường uống.
Xử trí
Trong trường hợp quá liều cấp tính, có thể làm rỗng dạ dày bằng cách rửa dạ dày hoặc gây nôn. Dùng các thuốc giải độc cụ thể cho thuốc pracetam. Trong trường hợp quá liều, chủ yếu là điều trị triệu chứng và có thể bao gồm thẩm phân máu; các biện pháp điều trị chung cũng được khuyến cáo.
Pracetam được thải trừ 50 – 60% trong 4 giờ thẩm phân máu.
- Đặc tính dược lực học**
Nhóm dược lý: Thuốc kích thần và hướng trí khác.
MS ATC: N06B03.
Trong các thử nghiệm trên động vật, pracetam cải thiện sự giảm chuyển hóa của não bằng cách kích thích sự phân hủy oxy hóa glucose thông qua con đường pentose phosphat, làm tăng sự luân chuyển ATP, tăng nồng độ cAMP trong tế bào thần kinh, kích thích adenylat kinase, kích thích chuyển hóa phospholipid với tăng sự kết hợp 32p trong phosphatidylcholin và -inositol, thúc đẩy quá trình sinh tổng hợp và tổng hợp protein hoặc tốc độ luân chuyển của cytochrom b5 lên enzym hỗ hấp trong điều kiện thiếu oxy.
Pracetam gây ra sự gia tăng mật độ của các thụ thể α-cholino và tăng sự luân chuyển dopamin ở động vật lớn tuổi. Nó hỗ trợ việc truyền kích thích và chuyển tiếp đến các vùng não khác nhau với sự cải thiện của phổ điện não đồ (EEG). Kiểm tra EEG cho thấy sự gia tăng thành phần alpha cũng với sự giảm đồng thời thành phần theta và delta.
Pracetam làm suy giảm khả năng học tập và trí nhớ ở bệnh nhân.
Pracetam có tác động huyết học trên tiểu cầu, hồng cầu, và thành mạch bằng cách làm tăng tính biến dạng của hồng cầu và giảm kết tập tiểu cầu, giảm kết dính hồng cầu vào thành mạch và giảm cơ mao mạch.
– **Tác dụng lên hồng cầu**
Ở những bệnh nhân bị bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm, pracetam cải thiện tính biến dạng màng tế bào hồng cầu, giảm độ nhớt của máu và ngăn ngừa sự hình thành các đám hồng cầu.
– **Tác dụng lên tiểu cầu**
Trong những nghiên cứu *in vitro* ở người tình nguyện khỏe mạnh và ở bệnh nhân có hội chứng Raynaud, liều pracetam tăng đến 12 g thường đi kèm với giảm chức năng tiểu cầu phụ thuộc liều dùng so với các trị số trước khi điều trị (các xét nghiệm kết tập tiểu cầu gây bởi ADP, collagen, epinephrin và phospho thích (PTG)), mà không có sự thay đổi đáng kể về số lượng tiểu cầu. Trong các nghiên cứu này, pracetam làm kéo dài thời gian chảy máu.
– **Tác dụng lên mạch máu**
Trong những nghiên cứu *in vitro* ở động vật, pracetam ức chế co mạch và làm mất tác dụng của nhiều loại thuốc co mạch khác nhau. Pracetam không có tác động giãn mạch và không tạo hiện tượng “lún cục”, không có tác dụng làm chậm dòng máu hoặc chảy ngược dòng hoặc làm tụt huyết áp.
– Ở người tình nguyện khỏe mạnh, pracetam làm giảm kết dính hồng cầu vào nội mạc mạch máu và cũng có tác dụng kích thích trực tiếp lên sự tổng hợp prostacyclin ở nội mạc mạch máu lành lặn.
– **Tác dụng lên các yếu tố đông máu**
Ở người tình nguyện khỏe mạnh, liều pracetam đến 9,6 g đã làm giảm nồng độ của fibrinogen và các yếu tố von Willebrand trong huyết tương (VIII: C, VIII R: AG; VIII R: vW) đến 30 – 40% và làm tăng thời gian chảy máu so với trước khi điều trị.
– Ở bệnh nhân có hội chứng Raynaud nguyên phát và cả thứ phát, pracetam liều 8 g ngày dùng trong 6 tháng đã làm giảm nồng độ của fibrinogen và các yếu tố von Willebrand trong huyết tương (VIII: C; VIII R: AG; VIII R: vW (RCF)) đến 30 – 40%, giảm độ nhớt của huyết tương và làm tăng thời gian chảy máu so với các trị số trước khi điều trị.
- Đặc tính dược động học**
Pracetam được hấp thu nhanh và hoàn toàn sau khi uống. Sinh khả dụng toàn thân tương đối so với giá trị AUC sau khi tiêm tĩnh mạch là 100% (liều duy nhất 800 mg pracetam i.v. đạt được sau 30 phút (t_{max}) là 15 – 19 μg/ml. Không phân biệt được dùng thuốc, thời gian bán thải trong huyết tương trung bình là 5,2 giờ (4,4 – 7,1 giờ) hoặc 7,7 giờ trong dịch não tủy. Trong nghiên cứu *in vitro*, pracetam liên kết với protein huyết tương khoảng 15%. Thể tích phân bố khoảng 0,6 lít/kg. Tổng độ thanh thải trong huyết tương khoảng 120 ml/phút. Chất chuyển hóa và các dược chất tìm thấy.
Trong trường hợp suy thận, quá trình bài tiết bị chậm lại, do đó cần giảm liều theo giá trị nito hoặc creatinin còn lại để tránh tác dụng tích lũy. Pracetam có thể thẩm phân 60 – 60%.
Pracetam đi qua hàng rào nhau thai và có thể phát hiện được trong huyết tương của thai nhi và trong nước ối (43 bệnh nhân; 2,4 hoặc 6 g pracetam i.v. đến 3 giờ trước khi sinh). Nồng độ trong huyết tương của thai nhi thấp hơn ở mẹ khoảng 10 – 30%. Tuy nhiên, thời gian bán thải trong huyết tương ở trẻ sơ sinh không phụ thuộc vào liều lượng là 200 phút, gần gấp đôi thời gian của mẹ (98 – 112 phút). Pracetam được bài tiết qua sữa mẹ.
Sinh khả dụng:
Pracetam có sinh khả dụng là 100% khi dùng đường uống.
- Quy cách đóng gói**
Vi 10 viên. Hộp 10 vi.
Chai 100 viên. Hộp 1 chai.
- Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc**
17.1. **Điều kiện bảo quản**
Trong bao bì kín, nơi khô. Nhiệt độ không quá 30°C.
17.2. **Hạn dùng**
36 tháng kể từ ngày sản xuất.
17.3. **Tiêu chuẩn chất lượng**
TCCS.
- Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc**



Công ty TNHH LD Stellapharm - Chi nhánh 1
Số 40 đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore,
P. An Phú, Tp. Thuận An, T. Bình Dương, Việt Nam
ĐT: (+84 274) 3767 470 Fax: (+84 274) 3767 469